

Apoiar a Pessoa Autista Monotrópica ao Longo da Vida

Guia para Profissionais de Saúde e Praticantes

Objetivo. Este guia explica o que é uma mente autista monotrópica, como as suas características mudam ao longo da vida e como os profissionais de saúde e praticantes podem **interagir, estimular (engajar) e apoiar** pessoas autistas desde a primeira infância até a velhice. Baseia-se na teoria do **monotropismo** do autismo — uma explicação baseada na atenção e neuroafirmativa desenvolvida pelos pesquisadores autistas Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser (2005) — e em evidências revisadas por pares e orientações clínicas/práticas onde existam. Não substitui a avaliação individualizada; cada pessoa autista é diferente.

Nota sobre a linguagem. Este guia utiliza a **linguagem de identidade primeiro** ("pessoa autista"), que é a preferência da maioria da comunidade autista e é consistente com a teoria de origem. Algumas pessoas e famílias preferem a linguagem de pessoa primeiro ("pessoa com autismo"); siga a preferência do indivíduo. O guia evita deliberadamente termos baseados em déficits ("desordenado", "deficiente", "sintoma"), exceto quando cita critérios clínicos, e, em vez disso, descreve diferenças com pontos fortes e desafios. O monotropismo é uma lente; uma minoria de pessoas autistas não sente que ela as descreve, e ela deve complementar, não substituir, a escuta do indivíduo.

Parte 1 — O Que É uma Mente Autista Monotrópica?

O monotropismo propõe que as mentes funcionam como um **sistema de interesse**: somos atraídos por muitas coisas, esses interesses puxam a nossa atenção, e a **atenção é um recurso limitado** pelo qual os processos mentais competem (Murray, Lesser & Lawson, 2005). A diferença entre a cognição autista e a não autista é enquadrada como uma diferença em *como a atenção é alocada*, não como um déficit.

"Em qualquer momento, a quantidade de atenção disponível para um indivíduo consciente é limitada. Há uma competição entre os processos mentais por esse recurso escasso." — Murray, Lesser & Lawson (2005), via National Autistic Society (NAS, 2025).

Uma mente **monotrópica** tende a despertar **menos interesses ao mesmo tempo**, mas cada interesse ativo captura uma **parcela desproporcional e intensa** dos recursos de processamento, produzindo um **"túnel de atenção"** estreito e profundo. Tudo fora do túnel é processado minimamente. Uma mente **politrópica** (o modo mais comum, não autista) distribui a atenção por mais interesses e alterna entre eles de forma mais fluida (Murray, Lesser & Lawson, 2005; F. Murray, 2018).

A teoria faz três previsões centrais que se mapeiam na experiência autista cotidiana (F. Murray, 2018; Dwyer, 2025; NAS, 2025):

1. **Intensidade dentro do túnel** — foco vívido e profundo que apoia a especialização, a criatividade e estados de **fluxo (flow)**.
2. **Processamento reduzido fora do túnel** — estímulos, pistas sociais e até sinais internos (fome, dor, necessidades fisiológicas) podem não ser registrados.
3. **Dificuldade em alternar** — as transições entre estados atencionais são lentas e exigem esforço; isto é a **inércia autística**.

1.1 O perfil característico num relance

Domínio	Característica informada pelo monotropismo
Atenção / interesse	Foco profundo e estreito; poucas trilhas simultâneas; "interesses especiais" são centrais, alegres e significativos, não periféricos

Domínio	Característica informada pelo monotropismo
Sensorial	Hiper-responsividade (um estímulo intrusivo capturado no túnel é sentido intensamente); hipo-responsividade (quando absorvido em outro lugar, estímulos/dor podem não ser registrados); busca sensorial (um estímulo agradável no túnel é perseguido intensamente) — uma explicação <i>unificada</i>
Interocepção e corpo	Reduzida consciência de fome, sede, dor, fadiga, necessidades fisiológicas quando em estado de fluxo ("desconexão interoceptiva")
Alternância / função executiva	Inércia autística — dificuldade em começar, parar ou mudar de trilha; não é uma "disfunção executiva" genérica
Social / comunicação	O processamento social multicanal é custoso; interpretação literal; necessidade de tempo de processamento; o problema da dupla empatia significa que o mal-entendido é <i>bidirecional</i> , não um déficit autista
Rotinas e stimming	As rotinas reduzem as decisões concorrentes e a carga mental; o stimming fornece um input previsível e autocontrolado que filtra a sobrecarga e restaura o equilíbrio
Pontos fortes	Especialização, detecção de padrões, concentração sustentada, fluxo, honestidade, profundidade de conhecimento, imersão criativa

1.2 Os riscos ao bem-estar que se seguem

Compreender o *mecanismo* torna os riscos previsíveis e — crucialmente — preveníveis:

- **Cisão monotrópica (monotropic split)** (termo cunhado por Tanya Adkin): a dissonância mental e o esgotamento resultantes de ser forçado a dividir ou alternar rapidamente a atenção de formas politrópicas; isso "pode ter efeitos desastrosos tanto a curto quanto a longo prazo" (F. Murray, 2023).
- **Meltdowns e shutdowns** são respostas **involuntárias** do sistema nervoso à sobrecarga, não escolhas comportamentais ou "birras". Um **meltdown** é visível (choro, gritos, andar de um lado para o outro, stimming, tentativas de escapar); um **shutdown** é o espelho internalizado — retirada, falta de resposta, desengajamento, um "desligamento" protetor para conservar energia (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism). Ambos

requerem um **tempo de recuperação** substancial (às vezes dias) e são agravados pela falta de compreensão alheia.

- **Burnout autístico** é "uma síndrome... resultante de estresse crônico na vida e um desajuste entre expectativas e habilidades sem apoios adequados", caracterizado por **exaustão generalizada e a longo prazo (tipicamente 3+ meses), perda de função e redução da tolerância a estímulos** (Raymaker et al., 2020). É **distinto do burnout profissional e da depressão clínica**, está ligado a **comportamentos suicidas** e é agravado por ser ensinado a **mascarar/camuflar** traços autistas. A recuperação está associada à **aceitação e apoio social, tempo livre / redução de expectativas e a "fazer as coisas de uma forma autista" / desmascarar (unmasking)** (Raymaker et al., 2020).
- **Mascaramento / camuflagem (masking / camouflaging)** (esconder traços autistas para parecer não autista) é exaustivo e está associado a ansiedade, depressão e diagnósticos perdidos — particularmente entre mulheres e meninas, que são mais frequentemente socializadas para mascarar (F. Murray, 2023; Pearson & Rose, 2021; Bradley et al., 2021).
- **Ruminação / "loops de preocupação"**: o mesmo tunelamento que produz interesses profundos pode fixar-se em preocupações e ansiedades (Hallett, 2021; F. Murray, 2023).

1.3 Estado da evidência (seja honesto consigo mesmo e com os clientes)

O monotropismo ressoa fortemente com a experiência vivida por autistas e é cada vez mais citado em pesquisas, mas permanece como uma teoria **descritiva** com testes experimentais diretos limitados e uma base de medição imatura — o **Questionário de Monotropismo** (Garau et al., 2023) é a única ferramenta dedicada e ainda está amadurecendo (Dwyer, 2021; Dwyer, 2025). Evidências convergentes incluem o desengajamento lento/ "pegajoso" da atenção em crianças autistas (Landry & Bryson, 2004; meta-análise: Sacrey et al., 2015) e uma literatura emergente sobre o **fluxo autista** (Heasman et al., 2024). Trate o monotropismo como uma *heurística clínica* poderosa — não como um rótulo diagnóstico.

Parte 2 — Princípios Transversais para Todos os Praticantes

Antes das seções por faixa etária, estes princípios aplicam-se **em todas as etapas da vida e em todos os contextos**. Eles são o núcleo prático de "como interagir e lidar" bem com uma pessoa monotrópica.

1. **Encontre a pessoa onde a atenção dela está.** A implicação prática mais citada do monotropismo é trabalhar *com* o interesse atual da pessoa, em vez de contra ele. Os interesses são "alavancas", não obstáculos a serem redirecionados (F. Murray, 2018; Wood, 2019; Lawson). *"Trate os interesses como algo com que trabalhar"* (F. Murray, 2018).
2. **Proteja o túnel de atenção; minimize a "cisão monotrópica".** Evite interrupções, mudanças rápidas forçadas de tarefa e multitarefa desnecessária. Quando uma mudança for inevitável, dê **avisos e tempo de transição** (ver §3). Como o engenheiro autista Jamie Knight formula o planejamento no local de trabalho: construa "**túneis, não tarefas**", e deixe que *o ambiente abra um espaço para o túnel passar* em vez de forçar a pessoa a perfurá-lo (Knight, 2021/2022).
3. **Respeite os interesses profundos como recursos de bem-estar.** Os interesses especiais proporcionam alegria, estabilidade, identidade, aprendizagem e recuperação do burnout; não são "obsessões" a serem limitadas (F. Murray, 2023; Mantzalas et al., 2022). Reduzir o acesso a eles é um risco clínico, não um tratamento.
4. **Reduza a carga sensorial desnecessária** e projete ambientes acessíveis (luzes mais fracas, menos poluição visual, evite luzes fluorescentes e cheiros fortes sempre que possível) (NAS, 2025; F. Murray, 2023).
5. **Comunique-se de forma clara e literal.** Diga exatamente o que quer dizer; evite sarcasmo, pedidos indiretos e dependência excessiva apenas do tom/expressão; permita **tempo extra de processamento**; ofereça informações por escrito. Não equívoco uma resposta lenta com desinteresse ou falta de compreensão (F. Murray, 2023).
6. **Pratique a postura da dupla empatia.** Reconheça que as falhas de comunicação são **bidirecionais** (Milton, 2012). Quando algo correr mal na interação, pergunte-se o que *você* pode estar a deixar passar, em vez de atribuir a falha a um déficit da pessoa autista.

7. Apoie a agência e a autenticidade; não force o mascaramento.

Reduza a pressão para "passar" como não autista. Suprimir stims ou a comunicação natural é prejudicial (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020; Pearson & Rose, 2021).

8. Construa previsibilidade e rotinas *com* a pessoa, não *para* ela.

Rotinas impostas muitas vezes resultam em resistência; rotinas co-criadas reduzem a carga de decisão e são bem-vindas (F. Murray, 2022).

9. Planeje a recuperação. Após eventos de alta demanda (visitas clínicas, transições, demandas sociais), espere e permita o tempo de descanso, o stimming e o acesso aos interesses.

10. Ouça o indivíduo como o especialista em sua própria experiência.

O autoinforme é a evidência primária; o Questionário de Monotropismo (Garau et al., 2023) pode ser um útil *iniciador de conversa*, não um diagnóstico.

Parte 3 — O Guia ao Longo da Vida

Cada seção cobre: **(a) o que você pode observar**, **(b) como interagir**, **(c) como estimular / engajar**, e **(d) como apoiar / lidar com desafios**.

3.1 Primeira Infância (aproximadamente 0–5 anos)

(a) O que você pode observar. Foco intenso em objetos/tópicos específicos; interesses intensos que emergem cedo (muitas vezes mais cedo do que em crianças não autistas); alinhar, classificar, categorizar e criar padrões como forma de brincar; atenção conjunta reduzida ou atípica e resposta ao nome; **desengajamento lento da atenção** ("olhar pegajoso") — mensurável desde a infância e um dos primeiros sinais; hiper ou hipo-responsividade sensorial; rotinas e brincadeiras repetitivas; meltdowns em transições. Uma criança monotrópica pode estar profundamente absorvida e não registrar muita coisa fora do túnel, incluindo fome, dor ou o fato de um progenitor ter saído da sala (Landry & Bryson, 2004; F. Murray, 2023; Donzelli, 2021; Lawson, sobre permanência do objeto).

(b) Como interagir. Entre no túnel de atenção da criança em vez de puxá-la para fora dele — **junte-se à brincadeira e ao interesse dela primeiro**, e então expanda gentilmente a partir daí. Use o interesse para construir conexão e atenção compartilhada (Lawson). Use linguagem clara, lenta e literal; permita tempo de processamento; não force o contato visual (o contato visual pode, por si só, consumir recursos atencionais escassos) (F. Murray, 2023). Reduza a carga sensorial na sala.

(c) Como estimular / engajar. Use o **interesse intenso da criança como a ponte para a aprendizagem e o desenvolvimento de competências** — sequenciamento, linguagem, contagem, habilidades motoras e de brincar podem todos ser praticados *através* do interesse (Lawson; Wood, 2019; BERA, sobre estados de fluxo na sala de aula). Apoie a **atenção conjunta** emergente através de brincadeiras baseadas no interesse e no relacionamento (o modelo JASPER e abordagens semelhantes baseadas no interesse/brincar visam a atenção conjunta e o brincar simbólico; Kasari et al., 2006). Honre a **cultura do brincar autista** — alinhar, classificar e a exploração sensorial são brincadeiras válidas, não brincadeiras "erradas" a serem corrigidas (Donzelli, 2021).

(d) Como apoiar / lidar. Gerencie as **transições** com cronogramas/temporizadores visuais, contagens regressivas, avisos verbais + visuais *antes* da mudança, objetos de "ponte" entre uma atividade e outra, e tempo extra; nunca puxe abruptamente uma criança para fora de um túnel de atenção (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Para **meltdowns**: mantenha a calma, reduza a estimulação, não julgue nem puna — eles são involuntários; garanta a segurança e, depois, permita a recuperação (Autism Society, 2025). Proteja o acesso ao *stimming* (é autorregulação) (F. Murray, 2023). Evite programas baseados em conformidade que treinem a eliminação de *stims* ou comportamentos naturais: estes aumentam o mascaramento e o dano a longo prazo (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

3.2 Infância Escolar (aproximadamente 6–12 anos)

(a) O que você pode observar. A escola é frequentemente o primeiro teste de estresse prolongado de um sistema monotrópico e é "um inferno para muitos monotrópicos — embora muitos de nós amem aprender" (F. Murray, 2023). A sala de aula, os corredores e os intervalos são tipicamente **muito barulhentos, visualmente poluídos e**

imprevisíveis, consumindo a atenção que deveria ir para a aprendizagem. As crianças podem parecer "malcomportadas" em transições, retirar-se nos intervalos, serem perseguidas por bullying devido a interesses "estranhos" ou brincadeiras autodirigidas, ou serem mal compreendidas por funcionários como desafiadoras, preguiçosas ou desinteressadas. A inércia manifesta-se como dificuldade em começar o trabalho, mudar de disciplina ou arrumar as coisas. Algumas crianças começam a mascarar pesadamente aqui, com custos para a saúde mental (F. Murray, 2023; Leatherland, 2019; NAS, 2025).

(b) Como interagir (professores, enfermeiros escolares, terapeutas). Reconheça que a resistência nas transições é um problema de **custo cognitivo**, não desafio. Forneça espaços quietos/com pouca luz (ex: "tarefas" na biblioteca durante o intervalo, um canto de calma). Construa relacionamentos através do interesse da criança. Comunique-se de forma literal, com antecedência e, quando possível, por escrito. Modele a postura da dupla empatia para os colegas e colegas de classe — enquadre as diferenças como diferenças, não como déficits (F. Murray, 2023; Wood, 2019).

(c) Como estimular / engajar (o "currículo monotrópico"). Faça do **interesse especial a espinha dorsal da aprendizagem**: ensine leitura, escrita, matemática, história e ciências *através* do interesse; permita tempo prolongado em fluxo guiado pelo interesse; projete tarefas em torno de poucas trilhas profundas, em vez de alternância constante (Wood, 2019, "interesses intensos... a chave para a inclusão educacional"; F. Murray, "Monotropism at School," 2019; BERA). Estados de fluxo são estados de aprendizagem — proteja-os: *"se um aluno se sente sobrecarregado... e você sabe que ele tem um interesse monotrópico em Lego, por que não criar um espaço tranquilo... e permitir tempo prolongado"* (BERA). Conecte-se com um aluno autista apaixonado *através* da paixão (Wood et al., 2022; Lawson).

(d) Como apoiar / lidar. Use cronogramas visuais, avisos de transição e atividades de ponte; dê tempo generoso de transição e reduza o número de transições por dia, sempre que possível (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Co-crie rotinas *com* a criança. Fique atento ao **burnout autístico** e à **"regressão de competências"** em crianças em idade escolar — estes geralmente refletem sobrecarga e uma mudança nos recursos atencionais, não a perda de uma habilidade inata, e a resposta é

reduzir as demandas e restaurar o acesso aos interesses/descanso, não pressionar mais (Edgar, 2024; Raymaker et al., 2020). Identifique e reduza a pressão para mascarar, especialmente em meninas, que são frequentemente ignoradas no diagnóstico porque mascaram (F. Murray, 2023). Use um guia de burnout para professores (ex: Edgar, 2023) e consulte os pais como especialistas em seus filhos.

3.3 Adolescência (aproximadamente 13–18 anos)

(a) O que você pode observar. A puberdade traz mudanças hormonais e cerebrais (poda sináptica, mielinização) que podem intensificar as respostas sensoriais e emocionais e perturbar um equilíbrio estabelecido. As demandas sociais da adolescência — hierarquias de pares, regras sociais implícitas, namoro, formação de identidade — são extremamente multicanal e exaustivas para um sistema monotrópico. As dificuldades de saúde mental (ansiedade, depressão) atingem o pico aqui; a ruminação / "loops de preocupação" podem tornar-se enraizados; a camuflagem intensifica-se, e muitos jovens autistas e de gêneros marginalizados são **identificados pela primeira vez apenas em crise**. Os interesses especiais tornam-se centrais para a identidade e para a recuperação. Amizades, quando de alta qualidade, são protetoras para a saúde mental (ARI, sobre a puberdade; Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023; Hallett, 2021; Sedgewick/Cook et al., via PMC9597130).

(b) Como interagir. Trate o jovem como o especialista em sua própria experiência. Use comunicação clara, literal e respeitosa; dê tempo de processamento e opções por escrito. Valide os interesses como legítimos e formadores de identidade. Esteja atento ao problema da dupla empatia nas interações com pares e clínicos. Proporcione **previsibilidade** em consultas e reduza a carga social/sensorial desnecessária (Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023).

(c) Como estimular / engajar. Canalize os interesses especiais em **estudos, projetos, portfólios, voluntariado e exploração de carreira precoce** — eles são o maior ativo motivacional e de desenvolvimento de competências do adolescente. Apoie a **identidade e a comunidade**: grupos de pares autistas, clubes de interesses especiais, mentores e comunidades autistas online podem transformar o bem-estar. Ensine a

autocompreensão do monotropismo para que o jovem possa defender as suas necessidades de atenção (em vez de internalizar "sou preguiçoso/estou quebrado").

(d) Como apoiar / lidar. Aborde a **saúde mental** proativamente; rastreie ansiedade, depressão, burnout e suicidalidade, reconhecendo que o **burnout autístico é distinto da depressão** e do burnout profissional e requer *redução de demandas, aceitação e desmascaramento*, não apenas TCC ou antidepressivos (Raymaker et al., 2020). Apoie as necessidades práticas e sensoriais da puberdade (menstruação, higiene, mudanças corporais) de forma explícita e concreta (ARI). Aborde o **dano do mascaramento** — reduza explicitamente a expectativa de camuflar. Ensine a autogestão de meltdowns/shutdowns e garanta que o jovem tenha uma rota de recuperação de baixa demanda. Planeje as **transições para a vida adulta** (educação, trabalho, transferência de cuidados de saúde) precocemente e com os interesses do jovem no centro. *(Inferência, sinalizada: a maior parte da orientação clínica aqui é extrapolada da literatura de burnout/mascaramento de adultos e relatos de experiência vivida autista, em vez de RCTs específicos para adolescentes.)*

3.4 Vida Adulta (aproximadamente 19–meia idade)

(a) O que você pode observar. Muitos adultos autistas — especialmente mulheres, pessoas de cor e aqueles sem deficiência intelectual — são **diagnosticados apenas na idade adulta** (a "geração perdida", Lai & Baron-Cohen). No ambiente certo, adultos monotrópicos trazem **especialização profunda, concentração sustentada, fiabilidade, detecção de padrões e honestidade** que são ativos genuínos. No ambiente errado — escritórios de plano aberto, interrupções constantes, expectativas vagas, carga sensorial, demandas sociais-políticas — enfrentam esgotamento crônico, mascaramento, meltdowns/shutdowns e **burnout autístico** (Knight, 2021/2022; Booth, 2021; Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022).

(b) Como interagir. Comunique-se **explicitamente e por escrito**; defina expectativas, prazos e normas sociais concretamente, em vez de implicá-los. Permita a comunicação escrita/assíncrona (e-mail, texto), que reduz a carga de canais. Dê tempo de processamento; não interprete uma pausa como resistência. Pergunte à pessoa quais acomodações a ajudam — ela é a especialista (F. Murray, 2023; Knight, 2021).

(c) Como estimular / engajar (no trabalho). Estruture a função em torno de **menos e mais profundos "túneis, não tarefas"** (Knight, 2021): minimize reuniões e interrupções, agrupe trabalhos superficiais, permita tempo de fluxo e forneça acesso a espaços silenciosos/com controle sensorial. Alinhe as tarefas com os **pontos fortes e interesses especiais**; a intensidade do foco autista, quando protegida, é um grande ativo de produtividade e inovação (Advanced Autism Services, 2025; Sachs Center; Booth, 2021). Construa **rotinas** com o adulto, e use acomodações legalmente disponíveis (ex: ADA/Equality Act) (Links ABA). Incentive o **"viver pequeno" (living little)** onde for útil — simplificar a vida para poucos focos de atenção pode melhorar significativamente a função e a felicidade (Knight, 2021).

(d) Como apoiar / lidar. Trate o **burnout autístico** como uma entidade clínica séria e distinta: reconheça a exaustão crônica, a perda de competências e a redução da tolerância a estímulos; avalie a suicidalidade (Raymaker et al., 2020). A direção de recuperação apoiada por evidências é **reduzir demandas e expectativas, proporcionar aceitação e apoio social, e permitir "fazer as coisas de uma forma autista" / desmascarar** (Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022). *Não* prescreva treinamento de habilidades sociais baseado em mascaramento como solução. Aborde a co-ocorrência de ansiedade, depressão, TDAH, problemas de sono e condições gastrointestinais (que são mais comuns em adultos autistas). Respeite que os **interesses especiais são protetores e restauradores**, não compulsões a serem limitadas (Mantzalas et al., 2022).

3.5 Adultos Mais Velhos e Idosos (aproximadamente 60+)

(a) O que você pode observar — e os limites honestos do nosso conhecimento. Esta é a **parte menos pesquisada da vida autista**: até 2024, a pesquisa sobre adultos autistas idosos representava apenas cerca de **0,4% da literatura sobre autismo** (embora tenha crescido ~392% desde 2012) (Klein et al., 2024). O que a evidência mostra é preocupante: os resultados para adultos autistas idosos são **geralmente ruins** nos quatro domínios do "envelhecimento saudável" (saúde e funcionamento; funcionamento cognitivo e físico; afeto positivo e controle; participação social). Eles apresentam **maiores taxas de condições médicas, baixas competências adaptativas, risco elevado de declínio cognitivo,**

atividade física limitada, altas taxas de condições de saúde mental, baixa qualidade de vida e redução da participação social/comunitária (Klein et al., 2024). Num exemplo australiano (idade 40+), apenas **3,3% preencheram os critérios para "envelhecimento bem-sucedido"** (Klein et al., 2024). Adultos autistas idosos têm **taxas mais altas de a maioria das condições de saúde** — transtornos de humor, problemas de sono, condições gastrointestinais e cardíacas — do que seus pares não autistas (Additude, resumindo estudos populacionais). Muitos adultos autistas idosos são **não diagnosticados** ("geração perdida"); os clínicos devem estar preparados para reconhecer o autismo em adultos idosos que apresentam diferenças sociais/sensoriais vitalícias, burnout ou crise de saúde mental (OAR; Klein et al., 2024).

(b) Como interagir. Todos os princípios transversais aplicam-se com peso extra: comunicação clara, literal e respeitosa; permita amplo tempo de processamento e informações por escrito; reduza a carga sensorial (mudanças na audição e visão agravam as diferenças sensoriais basais). Aplique explicitamente o **problema da dupla empatia** em contextos de cuidados.

(c) Como estimular / engajar. Preserve e **proteja interesses e rotinas vitalícios** — estes são âncoras de identidade, cognição e bem-estar, e podem ser especialmente protetores à medida que outras capacidades mudam. Adapte as atividades às **mudanças nas habilidades físicas e sensoriais** em vez de removê-las. Apoie a **comunidade e a conexão autista** para combater o grave isolamento social visto neste grupo (Klein et al., 2024; OAR). Incentive a atividade física suave e adaptada à pessoa (a inatividade física é um problema identificado) (Klein et al., 2024).

(d) Como apoiar / lidar.

- **O acesso aos cuidados de saúde** é uma lacuna crítica: muitos adultos autistas idosos evitam os cuidados devido a experiências negativas vitalícias e barreiras sensoriais/comunicativas; as clínicas precisam de treinamento (OAR; ver Parte 4).
- Fique atento ao **burnout autístico** — o risco acumula-se ao longo de décadas de mascaramento e necessidades não atendidas, e pode ser mal interpretado como depressão ou "declínio da idade" (Raymaker et al., 2020).

- Seja alerta para distinguir **mudança cognitiva vs. diferença autística**: distinguir padrões monotrópicos/de inércia autística de uma **demência/declínio cognitivo** genuíno é clinicamente difícil e pouco pesquisado; não assuma. Existe *muito pouca* pesquisa sobre autismo + demência/Alzheimer — sinalize a incerteza e avalie cuidadosamente (ABTAB; Klein et al., 2024).
- **Ambientes de cuidado** (casas de repouso, hospitais) são frequentemente hostis sensorialmente e disruptores de rotina; defenda espaços quietos, rotinas previsíveis, retenção de objetos/interesses significativos e treinamento de pessoal em autismo.
- Apoie o **planejamento de fim de vida e diretivas antecipadas** com comunicação clara e literal e respeito pela autonomia.
- *Inferência, sinalizada*: Como a evidência específica para o autismo na velhice é escassa, grande parte desta seção aplica o modelo de monotropismo ao longo da vida mais as descobertas gerais sobre o envelhecimento com autismo; trate como orientação de melhores práticas, não como protocolo estabelecido.

Parte 4 — Orientações Específicas para Profissionais de Saúde

Os contextos de saúde (luzes fluorescentes brilhantes, esperas imprevisíveis, instruções vagas, demandas sensoriais e sociais, dor e invasividade) estão entre os ambientes mais difíceis para pessoas monotrópicas e frequentemente desencadeiam shutdowns, meltdowns e a evitação de cuidados (Autism Society, 2025; PMC11305600 revisão narrativa sobre cuidados de saúde adaptados ao autismo). O seguinte é extraído da literatura de saúde amigável ao autismo e do **AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT)** (autismandhealth.org).

Antes da visita

- **Ofereça um questionário de acomodações pré-visita / a AHAT** para capturar as necessidades sensoriais, de comunicação e procedimentais específicas do indivíduo e produzir um relatório de acomodações personalizado (AASPIRE).

- **Forneça informações escritas e literais** sobre o que acontecerá, em que ordem e quanto tempo levará; ofereça fotos da sala/equipe, se possível.
- **Ofereça opções de agendamento:** primeira/última consulta (mais tranquilas), esperas mais curtas, sem clínicas ruidosas concomitantes.
- Permita que a pessoa **traga um apoiador de confiança** e seu próprio **kit sensorial** (fones de ouvido, óculos de sol, objetos de fidget/interesse) (CHOP; Grateful Care ABA).

Durante a visita

- **Reduza a carga sensorial:** luzes mais fracas, sala mais tranquila, menos pitidos, evite perfumes fortes (Autism Spectrum News; CHOP).
- **Comunique-se de forma literal e por escrito:** explique cada passo *antes* de realizá-lo; diga exatamente o que quer dizer; ofereça um resumo escrito e acompanhamento escrito ou online; permita longos silêncios para o processamento.
- **Não force o contato visual;** permita que a pessoa desvie o olhar, faça stimming ou use CAA.
- **Vá devagar; ofereça intervalos.** Tenha um kit de distração sensorial disponível (CHOP).
- **Respeite o túnel de atenção:** se a pessoa estiver usando um interesse ou stim para se autorregular durante um procedimento, não o interrompa.
- Aplique a **postura da dupla empatia** (Milton, 2012; Neurodivergent Insights): se a comunicação estagnar, assuma uma lacuna *mútua* e adapte-se, em vez de rotular o paciente como "difícil" ou "não colaborante".

Após a visita

- Forneça **acompanhamento escrito** (diagnóstico, instruções, próximos passos) em linguagem literal.
- Planeje **tempo de recuperação** e avise que a pessoa pode precisar descansar/entrar em shutdown depois.
- Documente as acomodações eficazes no registro para que sejam automáticas na próxima vez.

Reconhecimentos clinicamente críticos

- **O burnout autístico não é depressão.** Apresenta-se como exaustão crônica, perda de competências e redução da tolerância a estímulos, impulsionada por carga cumulativa e um desajuste entre expectativas e habilidades; tratá-lo como depressão (ou dizer para "se esforçar mais") agrava-o e aumenta o risco de suicídio. A recuperação requer redução de demandas, aceitação e permissão para desmascarar (Raymaker et al., 2020).
 - **O mascaramento na clínica é custoso.** Um paciente que "parece bem" em uma consulta de 15 minutos pode estar camuflando e pagando o preço depois; não deixe que uma apresentação mascarada anule o autoinforme ou o historial (Pearson & Rose, 2021; F. Murray, 2023).
 - **Dor e interocepção.** Uma pessoa monotrópica pode não notar ou reportar dor, fome, sede, fadiga ou sintomas internos até que sejam severos (Kelly Mahler, 2024; Lawson). Não equivoque "não reclamar" com "não sofrer"; pergunte proativamente, e considere que os padrões de sintomas reportados podem ser retardados ou atípicos.
 - **Medicação e efeitos colaterais.** Pessoas autistas frequentemente relatam respostas sensoriais e emocionais atípicas a medicamentos; comece com doses baixas, titule lentamente e monitore cuidadosamente o autoinforme.
 - **Meltdown/shutdown na clínica.** Estes são involuntários: reduza a estimulação, diminua as demandas, garanta a segurança, dê tempo e espaço, não contenha ou puna; um shutdown precisa de paciência calma e de baixo input, não de pressão para "engajar" (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism).
 - **Consentimento e capacidade.** Forneça informações de forma acessível e literal; permita tempo de processamento e tomada de decisão assistida; nunca assuma a falta de capacidade a partir de uma comunicação atípica.
 - **As acomodações ajudam a todos.** Cuidados sensorialmente amigáveis, previsíveis e comunicados claramente também beneficiam pacientes com TDAH, TEPT, ansiedade, perda sensorial, mudança cognitiva e muitos outros (UNC Health, 2025).
-

Parte 5 — O Que Evitar (Danos Comuns)

- Puxar uma pessoa abruptamente para fora de um túnel de atenção ou interromper o fluxo repetidamente (F. Murray, 2023).
- Treinar a eliminação de stims, diferenças de contato visual ou a comunicação natural (normalização baseada em conformidade) — aumenta o mascaramento e o dano a longo prazo (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).
- Enquadrar interesses especiais como "obsessões" a serem limitadas; reduzir o acesso aos interesses (Mantzalas et al., 2022).
- Impor rotinas/expectativas *sobre* a pessoa, em vez de co-criá-las (F. Murray, 2022).
- Utilizar linguagem baseada em déficits, patologizante; atribuir todos os problemas de interação à pessoa autista (Milton, 2012).
- Tratar o burnout autístico como depressão ou preguiça; pressionar a pessoa a mascarar mais (Raymaker et al., 2020).
- Clínicas sensorialmente hostis, procedimentos surpresa e instruções vagas (PMC11305600; AASPIRE).
- Assumir que as diferenças de um adulto idoso são "apenas envelhecimento" ou demência sem uma avaliação adequada (Klein et al., 2024).

Parte 6 — Questões Abertas e Ressalvas de Evidência (para uma prática honesta)

1. **A idade adulta é uma lacuna de pesquisa.** A maior parte da orientação para idosos é extrapolada; o autismo + demência, o autismo + menopausa/andropausa e os cuidados de fim de vida são amplamente não estudados (Klein et al., 2024). Seja transparente sobre a incerteza com pacientes e famílias.
2. **O monotropismo é descritivo, não mecanístico nem totalmente testado.** É uma excelente heurística clínica com suporte convergente crescente, mas não é um diagnóstico ou uma teoria completa (Dwyer, 2021; 2025).
3. **Nem todas as pessoas autistas são monotrópicas.** Uma minoria não se identifica com a estrutura; sempre centre-se no indivíduo (monotropism.org).

4. **A interseccionalidade é sub-abordada.** A maioria das pesquisas é focada em pessoas brancas, ocidentais, verbais e com baixas necessidades de apoio; apresentações, diagnósticos e necessidades diferem conforme o gênero, raça, habilidade intelectual e perfis de comunicação (Raymaker et al., 2020 limitações).
 5. **A co-ocorrência é a regra.** TDAH (AuDHD), ansiedade, depressão, diferenças de aprendizagem, condições GI/sono co-ocorrem comumente; o monotropismo pode ajudar a explicar a sobreposição AuDHD, e as pontuações do Questionário de Monotropismo são mais altas no AuDHD (Garau et al., 2023; NAS, 2025).
-

Fontes

1. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398> — via <https://monotropism.org/murray-lesser-lawson>
2. Murray, F. (2018, atualizado 2025). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
3. Murray, F. (2023). Monotropism and Wellbeing (keynote, Scottish Autism Research Group 2023). <https://monotropism.org/wellbeing>
4. Murray, F. (2019). Monotropism at School (originalmente em *Tes*). <https://monotropism.org/school/> — indexado em <https://monotropism.org/in-practice>
5. Murray, F. (2022). Understanding how routines can help autistic people thrive. *Thinking Person's Guide to Autism*.
<https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
6. National Autistic Society (Edgar, H. & Adkin, T., 2025). What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism.
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>
7. Dwyer, P. (2021). Revisiting monotropism. *Autistic Scholar*.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>

8. Dwyer, P. (2025). Monotropism: between obsessive joy and overwhelm. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
9. Garau, V. et al. (2023). Development and validation of a novel self-report measure of monotropism (the Monotropism Questionnaire). OSF preprint. <https://osf.io/ft73y/> — ferramenta em <https://dlcincluded.github.io/MQ/>
10. Landry, R. & Bryson, S. (2004). Impaired disengagement of attention in young children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>
11. Sacrey, L.-A. et al. (2015). Attention disengagement in autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, 56, 111–121.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>
12. Heasman, T. et al. (2024). Autistic flow theory. (Citado na NAS, 2025.)
13. Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32851204> — texto completo:
https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
14. Mantzalas, J. et al. (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2722>
15. Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking: understanding the narrative of stigma and the illusion of choice. *Autism in Adulthood*, 3(1).
<https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2020.0043>
16. Bradley, L. et al. (2021). Autistic adults' experiences of camouflaging and its perceived impact on mental health. *Autism in Adulthood*, 3(4), 320–329. (PubMed 36601637.)
17. Milton, D. (2012). On the epistemic and ontological value of the double empathy problem. *Dis & Soc*. Resumo: Reframing Autism,
<https://reframingautism.org.au/miltons-double-empathy-problem-a-summary-for-non-academics>
18. Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley. — e Lawson, W. (2025). Research by autistic

- researchers: an 'insider's view' into autism. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>
19. Wood, R. (2019). Autism, intense interests and support in school: from wasted efforts to shared understandings. *Educational Studies*. Resumo: <https://woodbug.blog/2019/03/27/autistic-children-and-intense-interests-the-key-to-their-educational-inclusion/>
 20. Wood, R. et al. (2022). *Learning From Autistic Teachers*. Jessica Kingsley.
 21. Leatherland, J. (2019). Understanding how autistic pupils experience secondary school (PhD thesis, Sheffield Hallam). <http://shura.shu.ac.uk/23231/>
 22. Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: a randomized controlled intervention study. *J Child Psychol Psychiatry*, 47, 611–620. (Referenciado via PMC5683273.)
 23. Donzelli, S. (2021). Autistic play at forest school: pretend play characteristics seen otherwise. *Forest School Association*. <https://forestschoollassociation.org/autistic-play-at-forest-school-pretend-play-characteristics-seen-otherwise/>
 24. Hallett, S. (2021). Loops of concern (guia sobre ruminação autista). <https://medium.com/@sonyahallett/loops-of-concern-ff792eebad03>
 25. Kelly Mahler (2024). Interoception and monotropism. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
 26. Knight, J. (2021). Staying put, monotropism & me (tunnels not tasks); (2022) Applying monotropism. <https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
 27. Booth, J. (2021). Why does work not work for autistic people? <https://janinebooth.com/content/why-does-work-not-work-autistic-people>
 28. BERA (2021). Autism: the benefits of monotropism and flow states and its applications for the classroom. <https://www.bera.ac.uk/blog/autism-the-benefits-of-monotropism-and-flow-states-and-its-applications-for-the-classroom>
 29. Autism Society (2025). Autistic meltdowns and shutdowns (factsheet). <https://autismsociety.org/>

30. Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. Understanding autistic meltdowns and shutdowns.
<https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>
31. Reframing Autism. All about autistic shutdowns: a guide for allies.
<https://reframingautism.org.au/all-about-autistic-shutdown-guide-for-allies>
32. AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT). <https://autismandhealth.org>
33. Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). Tips for more positive office visits for patients with ASD. <https://www.chop.edu/news/tips-more-positive-office-visits-patients-asd>
34. UNC Health (2025). Autistic patients need better care, accommodations in the medical office. <https://news.unchealthcare.org/2025/04/autistic-patients-need-better-care-accomodations-in-the-medical-office>
35. Autism Spectrum News. Creating sensory-friendly health care environments for autistic patients.
<https://autismspectrumnews.org/creating-sensory-friendly-health-care-environments-for-autistic-patients>
36. Klein, C. B. et al. (2024). Aging well and autism: a narrative review and recommendations for future research. *Healthcare*, 12(12), 1207.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203987> —
<https://doi.org/10.3390/healthcare12121207>
37. Organization for Autism Research (OAR). Aging on the autism spectrum. <https://researchautism.org/oaracle-newsletter/aging-on-the-autism-spectrum>
38. Lai, M.-C. & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. *Lancet Psychiatry*.
(Referenciado em Klein et al., 2024.)
39. Edgar, H. (2023). Supporting pupils through autistic burnout (teacher guide). <https://autisticrealms.com/supporting-pupils-through-autistic-burnout-teacher-guide/>
40. Edgar, H. (2024). Autistic young people: skills regression, burnout or a shift in monotropic attentional resources?
<https://autisticrealms.com/autistic-young-people-skills-regression-burnout-or-a-shift-in-monotropic-attentional-resources/>

41. Autism Awareness Australia. Understanding mental health in autistic teenagers. <https://www.autismawareness.com.au/navigating-autism/understanding-mental-health-in-autistic-teenagers>
42. Autism Research Institute (ARI). Understanding and supporting puberty in autistic girls and boys. <https://autism.org/understanding-and-supporting-puberty>
43. Neurodivergent Insights. Autism and the double empathy problem in medicine. <https://neurodivergentinsights.com/the-double-empathy-problem-in-medicine>
44. PieBru (2025). Monotropism: an interest-based account of autism (source brief). <https://github.com/PieBru/monotropism/blob/main/monotropism.md>
45. Narrative review: Autism-friendly healthcare — a narrative review of the literature (PMC11305600). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305600>